针刺联合药物、康复训练对脑梗死后运动性失语症患者的影响

郑惠慧,檀永超,李梦华,潘静
(广西壮族自治区钦州市第一人民医院,广西 钦州 535000)

摘要:目的 观察针刺联合药物康复训练对脑梗死后运动性失语症(CIMA)的影响。**方法** 将我院100例CIMA患者随机分为对照组与治疗组各50例。对照组采用药物阿司匹林、丁苯酞联合康复训练治疗,治疗组在对照组治疗基础上给予针刺治疗。比较两组临床疗效,失语症严重程度分级标准(BDAE)分级、北京医科大学汉语标准失语症成套测验法(ABC法)亚项评分,全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度,患侧大脑中动脉(MCA)血流速度(Vm),神经功能缺损程度评分(NIHSS评分)。**结果** 治疗后,治疗组总有效率高于对照组(P<0.05);两组BDAE分级、ABC法亚项评分、Vm高于治疗前,全血低切黏度、全血高切黏度、血浆黏度、NIHSS评分低于治疗前,治疗组上述指标的改善程度均优于对照组(P<0.05)。**结论** 针刺联合药物康复训练治疗CIMA患者疗效显著,改善病情,提高脑血流速度,降低神经功能缺损程度。

关键词: 脑梗死;运动性失语症;针刺;药物;康复训练
中图分类号: R277.7 **文献标识码:** B **DOI:** 10.3969/j.issn.1008-987x.2025.06.22

Effects of acupuncture combined with medication and rehabilitation training on motor aphasia in patients after cerebral infarction

ZHENG Hui-hui, TAN Yong-chao, LI Meng-hua, PAN Jing
(The First People's Hospital of Qinzhou, Qinzhou 535000)

Abstracts: Objective To observe the effects of acupuncture combined with medication and rehabilitation training on motor aphasia in patients after cerebral infarction (CIMA). **Methods** A total of 100 CIMA patients were randomly divided into control group and treatment group of 50 patients each. Control group was treated with the aspirin and butylphthalide combined with rehabilitation training, while treatment group received acupuncture on the basis of control group. Clinical efficacy was compared, including the severity grading of aphasia using the Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) grading, sub-item scores of the Chinese Standard Aphasia Test (ABC method) developed by Peking University, whole blood low-shear viscosity, whole blood high-shear viscosity, plasma viscosity, blood flow velocity (Vm) in the affected middle cerebral artery (MCA), and neurological function deficiency NIHSS scores. **Results** After treatment, the total effective rate in treatment group was higher than that in control group (P<0.05); both groups showed improvement in BDAE grading, ABC method sub-item scores, and Vm compared to before treatment, with treatment group scoring higher than control group (P<0.05); both groups had lower whole blood low-shear viscosity, whole blood high-shear viscosity, plasma viscosity, and NIHSS scores compared to before treatment, with treatment group showing lower values than control group (P<0.05). **Conclusion** Acupuncture combined with medication and rehabilitation training has a significant effect on patients with CIMA by improving their condition, enhancing cerebral blood flow velocity, and reducing the degree of neurological function deficiency.

Keywords: Cerebral infarction; Motor aphasia; Acupuncture; Medications; Rehabilitation training

基金项目:广西壮族自治区中医药管理局自筹经费科研项目(项目编号:GXZYN20230661)。
作者简介:郑惠慧(1983-),女,广西壮族自治区钦州市第一人民医院中医科副主任医师,研究方向:中西医结合及全科医学。

中国知网 https://www.cnki.net

脑梗死是多种原因引起脑血液供应不足，脑组织出现缺血缺氧最终坏死的损伤。肢体感觉运动障碍、言语障碍是其常见并发症，25%脑血管疾病伴言语障碍，包括失语症、构音障碍、言语失用，以运动性失语常见[1]。目前药物治疗或语言康复训练疗效有限[2]。脑梗死后运动性失语症（CIMA）在中医学归为“风喑”等，为本虚标实之证，标实是气滞血瘀夹痰阻络，本虚是肝肾阴虚。发病之本是痰瘀阻络，风邪侵袭脉络，阻滞舌络，舌乏濡润，神失所主引发失语[3]。本研究观察针刺联合药物康复训练对CIMA患者的影响。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

将2022年3月—2025年3月我院100例CIMA患者随机分为对照组与治疗组各50例。对照组男23例，女27例；平均年龄（69.57±8.02）岁；平均病程（2.98±0.75）个月。治疗组男26例，女24例；平均年龄（69.45±7.23）岁；平均病程（2.91±0.80）个月。两组一般资料比较差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断标准[4-5]：口语表达困难，语言理解相对完整，皮层构音障碍，语法结构困难，找词困难，喜欢用简单结构语句，多用实词，缺乏虚词，口语表达障碍累及书面语言。中医诊断标准[6]：气虚血瘀证。主症：半身不遂，不语或言语蹇涩，口舌歪斜，感觉减退；次症：面色泛白，自汗出，气短乏力；舌苔白腻，黯淡，脉沉细。

2 治疗方法

对照组：予阿司匹林（拜耳医药公司，批准文号：国药准字HJ20120237）口服0.1 g/次，1次/d；丁苯酞胶囊（石药集团公司，批准文号：国药准字H20050299）口服0.2 g/次，3次/d。语言训练：应用卡片、图片、图册等对患者进行知觉理解测试和发音，在镜前练习口型、发音、自动型言语矫正，结合视听说，进行刺激、反应、反馈训练。吞咽训练：躯干前倾，颈部向前屈曲，向患侧旋转90°，食物从患侧口角溢出时，进食后躯干向健侧倾斜45°。治疗4周。

治疗组：在对照组治疗基础上给予针刺。取穴：人中、脑户、百会、天窗、风府、廉泉、翳风、灵道、天鼎、下关、复溜、通里。仰卧位或坐位，消毒穴位，采用0.30 mm×25 mm毫针（苏州针灸医疗器械公司），快速进针，进针深度13~20 mm，平补平泻法，针刺得气后留针30 min。治疗4周。

3 治疗结果

3.1 疗效判定标准[7]

显效：说话能力提高≥2级；有效：说话能力提高≥1级；无效：说话能力无变化。

3.2 观察指标

（1）BDAE分级：分为6级，级别高症状轻。（2）ABC法亚项评分：对信息量、流利性、复述、命名等评分，分值越高说明亚项能力越好[8]。（3）采集空腹静脉血4 mL，抗凝，在2 h内采用SA9000全血血液流变测试仪（赛科西德）检测全血低切黏度、高切黏度，血浆黏度。（4）采用数字化彩色经颅多普勒（德国DWL公司），测患侧大脑中动脉（MCA）Vm。NIHSS评分：计0~45分，分数高症状重。

3.3 结果

3.3.1 两组患者临床疗效比较：见表1。

表1 两组临床疗效比较（例）

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率（%）
治疗组	50	24	17	9	82.00*
对照组	50	17	15	18	64.00

与对照组比较，*P<0.05。

3.3.2 两组患者治疗前后BDAE分级比较：见表2。

表2 两组治疗前后BDAE分级比较（例）

组别	时间	0级	1级	2级	3级	4级	5级
治疗组	治疗前	8	24	9	9	0	0
（n=50）	治疗后	0	0	19*#	16	8	7
对照组	治疗前	5	20	15	10	0	0
（n=50）	治疗后	0	12	21*	9	8	0

与本组治疗前比较，*P<0.05；与对照组治疗后比较，#P<0.05。

3.3.3 两组患者治疗前后ABC法亚项评分比较：见表3。

表3 两组治疗前后ABC法亚项评分比较（分，$\bar{x}\pm s$）

组别	时间	信息量	流利性	复述	命名
治疗组	治疗前	6.82±1.39	15.62±2.53	16.72±1.74	15.27±1.84
（n=50）	治疗后	14.86±1.29*#	37.43±3.37*#	23.26±2.86*#	18.54±2.45*#
对照组	治疗前	6.68±1.47	15.53±2.72	16.32±2.75	15.18±2.13
（n=50）	治疗后	10.46±1.85*	21.74±3.22*	19.30±1.98*	17.48±1.53*

与本组治疗前比较，*P<0.05；与对照组治疗后比较，#P<0.05。

3.3.4 两组患者治疗前后血液流变学指标比较：见表4。

表4 两组治疗前后血液流变学指标比较（mPa · s，$\bar{x}\pm s$）

组别	时间	全血低切黏度	全血高切黏度	血浆黏度
治疗组	治疗前	23.10±2.75	5.70±0.25	2.28±0.24
（n=50）	治疗后	12.68±0.57*#	2.83±0.54*#	1.09±0.19*#
对照组	治疗前	23.41±2.39	5.83±0.74	2.24±0.21
（n=50）	治疗后	20.52±0.26*	3.96±0.60*	1.89±0.17*

与本组治疗前比较，*P<0.05；与对照组治疗后比较，#P<0.05。

3.3.5 两组患者治疗前后Vm及NIHSS评分比较：见表5。

表5 两组治疗前后Vm及NIHSS评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	时间	Vm（cm/s）	NIHSS评分（分）
治疗组	治疗前	40.14±5.51	16.32±1.87
（n=50）	治疗后	63.57±3.65*#	8.81±0.98*#
对照组	治疗前	40.69±4.02	16.30±1.29
（n=50）	治疗后	54.98±1.01*	10.58±1.75*

与本组治疗前比较，*P<0.05；与对照组治疗后比较，#P<0.05。

4 讨论

中国知网 https://www.cnki.net

生理情况下语言中枢位于优势半球，优势半球损伤后失语恢复依赖于优势半球未受累语言区和非优势半球镜像区语言功能网络重建。CIMA是脑梗死导致语言功能丧失或障碍，理解、形成、表达语言能力受损，和大脑左侧额下回后部Broca区病变有关，表现为口语障碍、谈话不流利，复述、阅读、书写等功能受损，听力理解良好，但对语法结构、词句顺序理解困难。CIMA分为3种模式[9]：(1)语调发音受损，病变限于下部运动皮质区。(2)言语启动延迟，和孤立性病灶累及额叶有关。(3)语调和发育障碍，病变位于颞顶叶导致音位性错。现代医学康复训练对CIMA治疗十分肯定，脑部受损后尽早康复训练，调动内部潜能，促进受损神经元自我修复，促进神经元周围神经再生[10]。

中医认为CIMA导致沟通障碍，气虚血瘀是中风病常见证型，年老体虚、气血羸弱，不能运化，气虚无法推动血行，化生痰瘀，闭阻脑窍，导致中风。风邪入侵，肢体活动不利，影响运动，舌强语蹇。针刺百会降低超氧化物歧化酶活性，抗氧化，保护脑组织的目的[11]。人中针刺减轻缺血再灌注损伤，减少脑梗死面积，促进神经修复，改善症状[12]。针刺脑户通调脑络督脉，扩张脑血管，改善脑血液循环[13]。翳风和风府针刺通关开窍，散风熄风，改善吞咽功能[14-15]。针刺天鼎和天窗通暗窍，活喉肌，利咽喉[16-17]。针刺廉泉疏通咽气血，提升语言、吞咽功能[18]。针刺下关激发舌根经气，通调舌肌，利言语[19]。复溜滋阴补肾[20]。通里清心开窍，善治暴不言，清心安神，治疗舌强不语等症[21]。针刺可扩张脑血管，改善局部血供，促进神经细胞恢复，改善语言中枢神经元细胞代谢，刺激皮层区血流量变化，改善血流循环，提高脑氧分压，改善组织营养，加强脑组织修复和脑细胞代谢。

综上所述，刺联合药物康复训练对CIMA患者疗效显著，改善病情和血液流变学，提高脑血流速度，降低神经功能缺损程度。

参考文献：

[1] 谌晓妍，孔艳芳.头穴丛刺长留针联合经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语症的临床疗效观察[J].长治医学院学报，2025，39(4)：355-359.
[2] 章丽雅，周亮，刘勇，等.互动式针刺结合言语训练治疗卒中后失语症疗效研究[J].浙江中西医结合杂志，2025，35(7)：632-636.
[3] 彭丽文.LINC与Schuell刺激疗法联合治疗脑梗死后运动性失语症的效果分析[J].中国实用医药，2025，20(9)：42-45.
[4] 全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经科杂志，1996，29(6)：381-383.
[5] 李胜利.言语治疗学[M].第2版.北京：华夏出版社，2014：65-73.
[6] 李平，吴钟璇，张云如，等.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报，1996，19(1)：55-56.
[7] 张绍岚.康复功能评定[M].北京：高等教育出版社，2009：238-240.
[8] 中华人民共和国卫生部医政司.中国康复医学诊疗规范(上册)[M].北京：华夏出版社，1998：143.
[9] 李笑仙，苏薇洁，俞璐，等.针刺治疗缺血性卒中后失语的机制研究[J].上海针灸杂志，2025，44(6)：660-666.
[10] 张颖.奥瑞姆自理模式联合语言康复训练对脑梗死后运动性失语症患者的影响[J].中国医药导报，2019，16(1)：90-93，97.
[11] 谌晓妍，孔艳芳.头穴丛刺长留针联合经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语症的临床疗效观察[J].长治医学院学报，2025，39(4)：355-359.
[12] 刘勇涛，刘晓鑫，谢立娟，等.圣愈汤结合醒脑开喑针刺疗法治疗脑卒中后失语症临床疗效及安全性观察[J].中华中医药学刊，2022，40(2)：211-214.
[13] 秦娜，胡国强.针刺神堂和脑户穴配合重复经颅磁刺激治疗中风后抑郁的效果[J].中国医药导报，2023，20(8)：79-82，98.
[14] 郁燕敏，张志鹏，邱晓怡，等.采用加味益气聪明汤联合翳风穴穴位注射治疗脾胃虚弱型感音性耳鸣的临床疗效观察[J].现代医学与健康研究电子杂志，2025，9(15)：102-104.
[15] 田永强，吴新贵.风府穴定位与治疗神经系统疾病的针灸法[J].中西医结合慢性病杂志，2025，2(3)：46-51.
[16] 李雨阳，刘燕观，胡惠惠，等.电项针联合天鼎穴治疗对卒中后顽固性呃逆疗效、证候积分、生活质量的影响[J].现代生物医学进展，2025，25(15)：2445-2450.
[17] 郭士杰，张凌云.天窗穴临床运用心得[J].浙江中医杂志，2021，56(5)：376.
[18] 邓小渝，徐冬梅，樊琼，等.舌三针联合穴位贴敷廉泉穴对缺血性脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能及表面肌电信号的影响[J].中医杂志，2025，66(15)：1559-1565.
[19] 齐超，刘潇，邱田田，等.齐刺法深刺下关穴联合太乙神针治疗风寒型三叉神经痛临床研究[J].针灸临床杂志，2024，40(11)：50-55.
[20] 魏腾腾，邓云鹏，何广帅，等.基于数据挖掘技术探析复溜穴主治病证及配伍规律[J].中国中医基础医学杂志，2025，31(1)：107-111.
[21] 王丽荣，吕艳丽，刘兢，等.不同手法针刺通里穴治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报，2021，38(6)：1162-1167.

(稿件修回日期：2025-09-20 编辑：任婕)

中国知网 https://www.cnki.net